

Exame

Nome	Maria Aparecida Da Silva	Nascimento	11/05/1947 (78 anos)	Sexo	Feminino
Início	10/09/2025 - 21:17:54	Tempo total	10:08:52 (608,9 min)		
Fim	11/09/2025 - 07:26:46	Tempo válido	09:56:22 (596,4 min)		

Condições na noite do exame

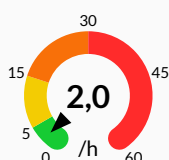
- ☐ Consumo de álcool
- ☐ Congestão nasal
- ☒ Sedativos
- ☐ Placa de bruxismo
- ☐ Marcapasso

Tratamentos na noite do exame

- ☒ CPAP
- ☐ Aparelho de avanço mandibular
- ☐ Terapia posicional
- ☐ Oxigênio
- ☐ Suporte ventilatório

Resultado

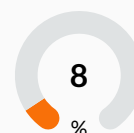
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO)^{1,2}



Valores de referência

IDO < 5	Normal
5 ≤ IDO < 15	Apneia do sono leve
15 ≤ IDO < 30	Apneia do sono moderada
IDO ≥ 30	Apneia do sono acentuada

Tempo com SpO₂ < 90%



Carga hipóxica⁴ • Risco cardiovascular

14 %min/hora

0 Risco menor

Risco maior 300+

Risco de FA^{5,6,7}

Baixo

Alto

Intensidade do ronco registrado

Silêncio
100 %

Baixo
0 %

Médio
0 %

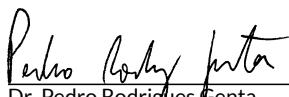
Alto
0 %

Exame de polissonografia realizado no dia 10/09/2025, iniciado às 21:17 e terminado às 07:26. O tempo total de registro foi de 10h08min (608 minutos) e o tempo válido foi de 9h56min (596 minutos). Foram monitorados os seguintes canais: oximetria de alta resolução, frequência cardíaca, movimento por actimetria e áudio para análise de ronco. Foram observadas 20 dessaturações de oxigênio durante o registro, com IDO de 2,0/hora (normal: inferior a 5/hora). A saturação da oxi-hemoglobina (SpO₂) teve valor médio de 91% e permaneceu abaixo de 90% durante 8% do tempo de registro (47 minutos). Foram detectados eventos de ronco durante 0% do tempo de registro.

A interpretação desses achados deve ser feita em conjunto com as informações clínicas complementares, anamnese, exame físico e resultados de outros exames.

Conclusão

Exame normal (IDO 2,0/hora), nas condições descritas e com o uso de CPAP.



Dr. Pedro Rodrigues Genta
CRM 87176-SP / RQE 48835-1

Exame

Nome	Maria Aparecida Da Silva	Nascimento	11/05/1947 (78 anos)	Sexo	Feminino
Início	10/09/2025 - 21:17:54	Tempo total	10:08:52 (608,9 min)		

Ficha médica

Medidas corporais

Respondido em 10/09/2025

Peso	80 kg
Altura	1,60 m
IMC	31,3

Medicamentos

Não respondido

☐ Nenhum

Sintomas Respondido em 10/09/2025

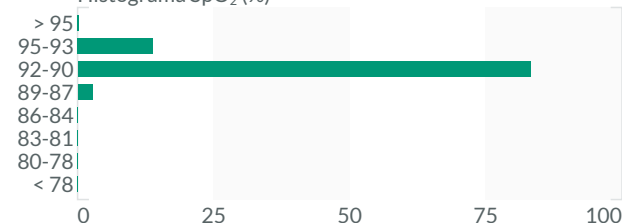
- ☐ Nenhum
- ☒ Ronco alto e frequente
- ☒ Sonolência excessiva diurna
- ☐ Sono não reparador
- ☒ Despertares frequentes
- ☒ Engasgos noturnos
- ☒ Refluxo gastroesofágico
- ☐ Cefaleia matinal
- ☒ Dificuldade de concentração
- ☒ Perda de memória
- ☐ Diminuição da libido ou disfunção erétil

Doenças associadas Respondido em 10/09/2025

- ☐ Nenhuma
- ☐ Hipertensão arterial
- ☐ Diabetes
- ☒ Dislipidemia
- ☐ Câncer
- ☒ Depressão
- ☐ Arritmia cardíaca
- ☐ Infarto agudo do miocárdio
- ☐ Angina
- ☐ Insuficiência cardíaca
- ☐ Acidente vascular cerebral (AVC)
- ☒ Bronquite / Enfisema
- ☒ Asma

Oximetria (SpO₂)

Histograma SpO₂ (%)



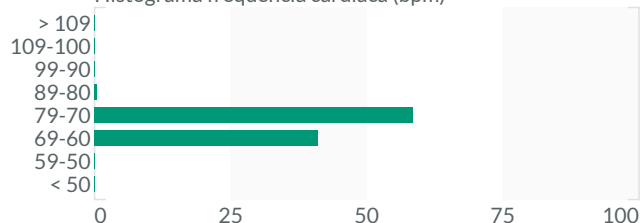
SpO ₂ mínima	87%
SpO ₂ média	91%
SpO ₂ máxima	97%
Tempo com SpO ₂ < 90%	47,8 min (8%)
Número de dessaturações ¹	20
Índice de dessaturações de oxigênio (IDO) ^{1,2}	2,0 /hora
Índice de dessat. de oxigênio sono (IDOs)	0,5 /hora
Carga hipóxica (hypoxic burden) ⁴	13,6 %.min/hora
Número de eventos de hipoxemia ³	0
Tempo total em hipoxemia ³	0,0 min (0%)

Análise de ronco

Tempo de gravação	607,0 min
Tempo com ronco total	0,0 min (0%)
Tempo com ronco baixo	0,0 min (0%)
Tempo com ronco médio	0,0 min (0%)
Tempo com ronco alto	0,0 min (0%)

Frequência cardíaca

Histograma frequência cardíaca (bpm)



Mínima	60 bpm
Média	70 bpm
Máxima	100 bpm

Fibrilação atrial (FA) estimada^{5,6,7}

Número de episódios	0
Tempo total em FA	-
Episódio de menor duração	-
Episódio de maior duração	-
Duração média dos episódios	-
Risco de FA	Baixo

Sono estimado

Tempo total de sono	472,0 min
Tempo para dormir	36,5 min
Tempo acordado pós-sono	98,0 min
Eficiência do sono	78%

Notas:

1. Considera-se uma dessaturação de oxigênio a queda temporária de pelo menos 3% no nível de saturação de oxigênio (SpO₂).
2. O índice de dessaturações de oxigênio (IDO) corresponde ao número de eventos dividido pelo tempo válido do exame.
3. Um evento de hipoxemia ocorre quando a SpO₂ permanece abaixo de 88% por 5 minutos consecutivos.
4. A correlação entre a carga hipóxica e o risco cardiovascular é baseada no artigo *The Sleep Apnea-Specific Hypoxic Burden Predicts Incident Heart Failure* (Azarbarzin et al. Chest. 2020; 158(2):739-750).
5. O risco de fibrilação atrial (FA) é estimado de forma indireta através da variação da onda de pulso do oxímetro.
6. O diagnóstico de FA e de outras arritmias cardíacas podem ser episódicos e variar noite a noite e deve ser confirmado por outras metodologias a critério médico.
7. A detecção de FA deste exame é realizada em pacientes maiores de 18 anos e considera apenas episódios com duração maior que 6 minutos. Possíveis episódios de FA com duração menor que 6 minutos não foram incluídos na análise.

Polissonografia de noite inteira (inclui polissonogramas)

Exame do Sono Biologix® Pro

Exame

Nome	Maria Aparecida Da Silva	Nascimento	11/05/1947 (78 anos)	Sexo	Feminino
Início	10/09/2025 - 21:17:54	Tempo total	10:08:52 (608,9 min)		

Polissonogramas

